

年之后为 2 月/次, 保持 2~3 年, 并对这一治疗过程保持随访。

试验组患者采用介入治疗联合膀胱灌注的方法: 膀胱灌注的治疗方法同对照组。手术后 2~3 周起行介入治疗, 治疗前对患者的血常规、心肾功能进行检查, 并进行普鲁卡因及碘试验。腹股沟备皮, 一般选右侧股动脉行 Seldinger 穿刺术, 在穿刺成功之后置入 5F 导管鞘, 通过鞘内插入 3~5FCobra 导管, 导管先插进左侧髂内动脉行 DSA 造影, 并以同样的方法注入化疗药物, 化疗药物用量由体表面积决定, 一般为顺铂 60~80mg、表阿霉素 40~60mg、氟尿嘧啶 750~1000mg。两侧髂内动脉的化疗药物分布一般为膀胱病变侧 2/3, 对侧 1/3。在化疗药物灌注之前应先注入 6mg 的格拉司琼预防消化道症状。在手术之后拆除导管鞘及导管, 对穿刺部位进行局部压迫 20min, 以加压绷带包扎 24h。嘱患者静卧休息, 在介入治疗后给予利尿、水化等相关处理, 给抗炎药物 3~5d, 间隔 4 周进行重复介入治疗, 3 次为 1 疗程, 之后每半年 1 次, 保持 2~3 年, 并对这一治疗过程保持随访。

1.3 随访 患者行膀胱镜下电切术或膀胱部分切除术后随访 3 年。介入治疗前与治疗 2 周对患者的血常规、心肾功能、心电图等进行检查, 了解患者是否有感染、心肾功能损害及骨髓抑制等症状。在术后 3 个月、6 个月以及 1 年对患者进行 CT、MRI 及超声复查。1 年后每半年复查一次, 持续 3 年, 随访期间经常与患者及家属进行联系, 了解患者的情况。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 19.0 统计软件进行统计学分析。计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示, 进行 t 检验; 计数资料以率表示, 进行 χ^2 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

随访 3 年内, 对照组累计复发率、转移率及病死率分别为 46.5% (20/43)、39.5% (17/43)、18.6% (8/43); 试验组累计复发率、转移率及病死率分别为 20.9% (9/43)、14.0% (6/43)、7.0% (3/43); 两组比较, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。

3 讨论

膀胱癌术后行介入治疗联合膀胱灌注能够有效预防肿瘤的复发及转移, 效果比较理想^[9]。介入治疗联合膀胱灌注具有协同抗肿瘤的作用, 髂内动脉灌注化疗药物可以使药物更好的聚集于病变部位, 增强对肿瘤细胞的杀伤力, 还可以减

少静脉小剂量化疗导致的肿瘤细胞出现多药耐药性, 并且灌注化疗可以有效减少流经其他器官的药量, 减少化疗药物的不良反应^[9]。随访 3 年内, 对照组患者累计复发率、转移率及病死率分别为 46.5% (20/43)、39.5% (17/43)、18.6% (8/43); 均高于试验组的 20.9% (9/43)、14.0% (6/43)、7.0% (3/43)。提示采用介入治疗联合膀胱灌注能够有效降低术后肿瘤的复发率、转移率以及病死率。

在动脉化疗中应注以下几点: (1) 超选择性插管的深度需超过髂内动脉后干分支, 避免出现体表组织坏死的不良反应。应采用双侧髂内动脉灌注, 并依据肿瘤发生部位调整两侧的化疗药物的药量。(2) 顺铂具有严重肾毒性, 介入治疗前后应进行利尿、水化等处理, 降低顺铂的肾毒性。本研究中, 经动脉灌注顺铂、氟尿嘧啶及表阿霉素在肿瘤治疗方面取得比较好的疗效, 在结合利尿、解毒、水化处理之后, 药物的毒副作用被大大降低。(3) 手术创伤没有完全修复之前不要进行化疗, 这样不但会损害机体免疫功能, 还会影响机体的恢复。在机体恢复正常之后应尽快开展化疗, 一般应在术后 2~3 周进行。

总之, 介入治疗联合膀胱灌注对行膀胱电切术或部分切除患者预防、降低肿瘤复发率及转移率并延长患者生存期方面都具有显著的效果, 是治疗膀胱癌的可行办法。

参考文献

- 1 吴渭贤, 朱希松, 孔宏伟. 膀胱癌术后联合采用介入治疗和膀胱灌注预防肿瘤复发和转移的临床应用价值探讨 [J]. 中国中西医结合急救杂志, 2008, 15 (7): 236-237.
- 2 王欣, 苏晶石, 刘铸, 等. 膀胱癌术后吡柔比星膀胱灌注预防复发的临床观察 [J]. 中华肿瘤防治杂志, 2011, 28 (3): 1045-1046.
- 3 王文明, 宋有军, 王书才. 术后早期膀胱灌注吡柔比星预防膀胱癌术后复发的疗效观察 [J]. 河南外科学杂志, 2010, 20 (5): 657-658.
- 4 吴渭贤, 邱菊生. 膀胱癌电切术后联合采用区域灌注介入治疗 + 膀胱灌注预防复发和转移的疗效分析 // 中华医学会第十八次全国放射学学术会议论文汇编 [J]. 2011.
- 5 卓文利, 徐廷昭, 吴卫真, 等. 丝裂霉素诱导式卡介苗膀胱灌注预防膀胱肿瘤术后复发的临床研究 // 第十六届全国泌尿外科学术会议论文集 [J]. 2009.

(收稿日期: 2014-05-13)

• 药品动态 •

抗菌药物与磺脲类药物相互作用可导致低血糖

一项最新的研究称, 对于接受磺脲类药物降血糖治疗的老年患者而言, 使用某些特定类型抗菌药物治疗可能会增加低血糖风险。

美国得克萨斯大学医学院 James S Goodwin 教授在接受路透社采访期间指出, “以往研究证实, 磺脲类药物治疗期间同时服用多种抗菌药物可增加患者因低血糖的住院风险。因此, 接受磺脲类药物治疗的患者应避免使用这些抗菌药物。对于大部分患者而言, 目前已有疗效相似、且无药物相互作用的抗菌药物可供选择。” Goodwin 教授及其团队将研究结果在线发表在 2014-09-01 的 JAMA Internal Medicine 杂志上。

(摘自: 丁香园)